

③

免疫チェックポイント阻害薬:薬剤師の実践ポイント

irAEを見逃さないための関わり方

1 服薬指導で伝えるポイント



「今までにない症状」はどんな些細なものでも報告するよう伝える(irAEの多様性)



下痢・皮疹などの初期症状の段階で連絡することの重要性を強調する



ステロイド治療中は感染予防(手洗い・うがい)の指導も追加する

2 処方監査・疑義照会のタイミング

- ☐ ステロイド治療開始時は、消化性潰瘍予防薬・骨粗鬆症対策等の付随治療が必要か確認する
- ☐ 免疫抑制薬追加時は、通常の感染対策に加えB型肝炎再活性化リスクも考慮する
- ☐ 既存の自己免疫疾患・臓器移植歴がないか、事前に薬歴で確認できているか確認する

3 施設間連携・情報共有のポイント



irAE発症時は関連診療科(内分泌内科、消化器内科等)との早期連携が必要



症状の推移・ステロイド減量スケジュールを医療機関間で共有する

4 実践チェックリスト

- ☐ 新規症状の訴えがあれば、まずirAEの可能性を考慮し情報を整理する
- ☐ ステロイド治療中の患者には、急な自己中断のリスク(離脱症状)も説明する
- ☐ 治療終了後も一定期間はirAEのモニタリングを継続する視点を持つ

irAEの対応は「早期発見・早期のステロイド介入」が鍵。疑わしきは報告してもらう関係づくりが最大の武器になる。